



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENGEMBANGAN KELAS IBU HAMIL DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BERBASIS APLIKASI ANDROID

Erni Hernawati



Pengembangan Kelas Ibu Hamil dengan Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi Android

Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pengembangan Kelas Ibu Hamil dengan Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi Android

Penulis: Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-63-4

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini berjudul **‘Pengembangan Kelas Ibu Hamil dengan Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi Android’**. Kehadiran buku ini merupakan upaya kami untuk berkontribusi dalam menghadirkan solusi terhadap permasalahan kesehatan ibu hamil, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap kesehatan kehamilan melalui media teknologi yang praktis dan inovatif.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan baru bagi para pembaca, khususnya akademisi, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat umum, mengenai bagaimana teknologi berbasis aplikasi Android dapat dimanfaatkan secara optimal dalam dunia kesehatan. Di dalamnya, kami membahas konsep dasar pengembangan aplikasi Android, proses implementasi, serta evaluasi keberhasilannya dalam membantu ibu hamil. Dengan pendekatan yang berbasis penelitian, buku ini juga memberikan bukti empiris tentang dampak positif aplikasi terhadap peningkatan kesadaran dan perilaku ibu hamil.

Sebagai salah satu inovasi di bidang kesehatan, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memotivasi para pembaca untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan solusi digital yang dapat menjawab

tantangan kesehatan masyarakat. Kami juga berharap buku ini mampu menginspirasi para tenaga kesehatan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media edukasi, sekaligus mendorong ibu hamil untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait kehamilan yang sehat.

Selain memberikan informasi yang relevan, buku ini juga mengajak para pembaca untuk memahami pentingnya pendekatan yang tepat dalam mengedukasi ibu hamil. Tidak semua informasi kesehatan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis aplikasi yang interaktif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan.

Kami juga ingin menekankan bahwa buku ini tidak hanya berbicara tentang teknologi semata, tetapi juga menyentuh aspek humanis dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Melalui aplikasi yang dirancang secara komprehensif, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi para ibu hamil di berbagai wilayah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan langsung.

Kami menyadari bahwa perjalanan penulisan buku ini tidak akan sempurna tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kolega, tenaga kesehatan, pengembang aplikasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran dari para pembaca akan sangat kami hargai untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengajak pembaca untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan. Semoga pula upaya kecil ini dapat menjadi bagian dari langkah besar dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Desember 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Konsep Dasar Kehamilan	8
A. Program Antenatal Care Serta Tujuannya	8
B. Standar Antenatal Care.....	10
C. Jenis Pelayanan Antenatal Care.....	20
Bab 3 Pemberdayaan Ibu Melalui Kelas Ibu Hamil	25
A. Konsep Ibu Hamil	25
B. Tujuan, Sasaran dan Output Kelas Ibu Hamil.....	26
C. Konsep Pendidikan kesehatan untuk Ibu Hamil	31
D. Materi Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.....	34
Bab 4 Pengembangan Teknologi dalam Pendidikan Kesehatan Ibu Hamil	37
A. Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Akses Kesehatan Ibu Hamil.....	37
B. Keunggulan Aplikasi Android dalam Pendidikan Kesehatan	40
Bab 5 Dampak Pengembangan Aplikasi Android terhadap Kualitas Kesehatan Ibu Hamil.....	46
A. Dampak Positif.....	46
B. Dampak Negatif	50
Bab 6 Penutup	58
Daftar Pustaka	61
Glosarium	65
Profil Penulis.....	68

Bab 1

Pendahuluan

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan Indonesia, 2017)

Berdasarkan data dari Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menunjukkan penurunan dengan kasus kematian ibu pada tahun 2012 sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. AKI sudah mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2015 dengan persentase penurunan sebanyak 19%. Namun ketika dibandingkan dengan Negara ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) pada tahun

2015 angka kematian Ibu di Indonesia masih menempati peringkat kedua tertinggi setelah Laos 357/100.000 kelahiran hidup, sedangkan negara-negara lain seperti, Timor Leste 300/100.000 kelahiran hidup, Filipina 198/100.000 kelahiran hidup, Myanmar 178/100.000 kelahiran hidup, Kamboja 161/100.000 kelahiran hidup, Vietnam 54/100.000 kelahiran hidup, Brunei Darusalam 54/100.000 kelahiran hidup, Malaysia 40/100.000 kelahiran hidup, Thailand 20/100.000 kelahiran hidup dan Singapura 10/100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan penyebabnya angka kematian ibu di Indonesia selain disebabkan secara langsung yaitu perdarahan 30% hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia-eklampsia) 27%, dan infeksi 7%. Penyebab lainnya menurut Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Barat tahun 2015 sebanyak 83/100.000 kelahiran hidup. Penyebab langsung kematian ibu adalah dengan komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia-eklampsia) 26%, perdarahan 28,4% dan sepsis 6,9%. Untuk penyebab tidak langsungnya meliputi akses pada layanan kesehatan kurang, cakupan imunisasi TT pada ibu hamil kurang, penanganan pada saat persalinan lebih banyak dilakukan di non-nakes. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil yang harus diberikan saat kunjungan. Keberadaan puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas juga sudah menerapkan konsep satelit dengan menyediakan puskesmas pembantu. (Profil Kesehatan Cimahi, 2017)

Sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak, Kementerian Kesehatan menetapkan

indikator persentase Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).

Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil. (Profil Kesehatan Indonesia, 2017

Upaya menurunkan kematian ibu menjadi prioritas utama program pembangunan kesehatan nasional melalui upaya peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas. Diperkirakan 74% dari kematian ibu dapat dihindari jika semua perempuan memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui deteksi dini risiko tinggi atau komplikasi kehamilan dan persalinan serta penanganan secara memadai (Hunt P, 2010).

Sebanyak 93,76% Puskesmas di Indonesia telah melaksanakan kelas ibu hamil yang berarti telah mencapai renstra Kementerian Kesehatan tahun 2017 yang sebesar 84%. Hampir seluruh provinsi telah

mencapai target renstra tersebut kecuali Maluku, Papua Barat, dan Papua. (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).

Tujuan pertemuan kelas ibu hamil yaitu untuk meningkatkan pengetahuan seputar pemahaman tentang kehamilan sesuai dengan keilmuan untuk membedakan antara mitos/kepercayaan dan fakta, perubahan dan adaptasi selama kehamilan, perawatan diri selama kehamilan, persiapan untuk perencanaan persalinan, tanda-tanda bahaya komplikasi selama kehamilan, perawatan diri selama masa nifas, perawatan bayi baru lahir dan perencanaan penggunaan kontrasepsi agar terciptanya sikap positif dan perilaku ibu yang menimbulkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan diri selama kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir. (Yuliani, 2021). Keikutsertaan ibu hamil dan keluarga pada kelas ibu hamil diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil dan keluarga. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Bidan sebagai tenaga lini terdepan (front line) dalam pelayanan kebidanan dituntut harus mampu dan terampil dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja bidan adalah penyediaan

panduan atau alat bantu dalam pelayanan. Secara formal alat bantu atau panduan pekerjaan didefinisikan sebagai perangkat eksternal yang memberikan pengetahuan langsung dan informasi untuk membantu, mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan kinerja individu dalam tugas mereka (Florez JF, 2011 & Arango, 2009).

Saat ini, media yang berkembang pesat dan mampu mempresentasikan pedoman kerja dengan mudah dan menarik salah satunya adalah smartphone berbasis android. Efektifitas smartphone android termasuk kemampuan multimedia, portabilitas tinggi, dan penyimpanan data lokal, berpotensi dapat membantu tenaga kesehatan dengan menyediakan informasi tentang manajemen kasus dan aplikasi pendukung keputusan yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan (Florez JF, 2011 & Arango, 2009).

Penggunaan ponsel saat ini meningkat pesat bahkan sampai kepedesaan dan sudah menjadi tren gaya hidup serta kebutuhan penting bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2015 pengguna ponsel sebesar 128% atau sekitar 315 juta pengguna, dimana rata-rata masyarakat Indonesia memiliki 1-2 ponsel aktif. Sebanyak 41,7% menggunakan ponsel jenis

smartphone atau android. Pertumbuhan ini mendorong munculnya program global yang menggunakan teknologi mobile untuk mendukung program kesehatan. Penerapan teknologi informasi kesehatan terutama dalam pelayanan antenatal, dapat memfasilitasi pemberian pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dapat mendorong perawatan lebih terkoordinasi dengan baik, meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman dan mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur, sehingga mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas. (McNabb M et al, 2015).

Bab 2

Konsep Dasar Kehamilan

A. Program Antenatal Care Serta Tujuannya

Antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan persalinan yang aman dan memuaskan. (Walyani, 2015)

Antenatal care adalah pengawasan selama kehamilan untuk mengetahui kesehatan umum ibu, menegakkan secara dini penyakit yang menyertai kehamilan, menegakkan secara dini komplikasi selama kehamilan (resiko tinggi, resiko merugikan dan resiko rendah). Asuhan antenatal juga untuk menyiapkan persalinan menuju *well born baby* dan *well health mother*, mempersiapkan perawatan bayi dan laktasi, serta memulihkan kesehatan ibu yang optimal saat akhir kala nifas (Ida, 2013)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2016, ANC atau *anteatal care* merupakan perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Melalui ANC berbagai informasi serta edukasi terkait kehamilan dan persiapan persalinan bisa diberikan kepada ibu sedini mungkin. Kurangnya pengetahuan mengenai tanda bahaya kehamilan sering terjadi karena kurangnya kunjungan ANC. Kurangnya kunjungan ANC ini bisa menyebabkan bahaya bagi ibu maupun janin seperti terjadinya perdarahan saat masa kehamilan karena tidak terdeteksinya tanda bahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 juga telah mengatur pelaksanaan ANC melalui pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar (Kemenkes RI, 2019). Disamping itu juga ada upaya percepatan penurunan AKI melalui kebijakan kemenkes yang mengacu pada intervensi strategis "Empat Pilar *Safe Motherhood*" dengan salah satu program berupa penerapan mutu pelayanan kesehatan ibu terhadap standar pelayanan. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil (Yuliani, 2021).

Antenatal Care atau pemantauan masa kehamilan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi,

2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi,
3. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi,
4. Mempersiapkan persalinan cukup bulan,
5. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian,
6. ASI eksklusif,
7. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Saifuddin, 2016).

B. Standar Antenatal Care

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar terdiri dari :

1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan
Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor risiko pada ibu hamil.

Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan risiko untuk terjadinya Cephalo Pelvic Disproportion (CPD)

2. Ukur Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg) pada kehamilan dan preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau tungkai bawah; dan atau proteinuria)

3. Nilai Status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas / LiLA)

Pengukuran LiLA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil berisiko Kurang Energi Kronis (KEK). Kurang energi kronis disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan atau tahun) dimana ukuran LiLA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan

pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.

5. Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester III bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali/menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali/menit menunjukkan adanya gawat janin.

6. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Berikan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila Diperlukan

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil diskriminasi status imunisasi T-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, disesuaikan dengan status imunisasi T ibu saat ini. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status imunisasi T5 (TT

Long Life) tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi. Pemberian imunisasi TT tidak mempunyai interval maksimal, hanya terdapat interval minimal. Interval minimal pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pemberian Imunisasi TT

Imunisasi TT	Jarak Pemberian	Lama Perlindungan
TT1		Langkah awal pembentukan kekebelan tubuh terhadap tetanus
TT2	1 Bulan setelah TT1	3 tahun
TT3	6 Bulan setelah TT2	5 tahun
TT4	12 Bulan setelah TT3	10 tahun
TT5	12 Bulan setelah TT4	≥ 25 tahun

7. Beri Tablet tambah darah (Fe)

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah (tablet zat besi dan asam folat) minimal 90 tablet selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama.

8. Periksa Laboratorium (Rutin dan Khusus) Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan

laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis/ epidemi (malaria, HIV, dan lain-lain). Sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tersebut meliputi:

a. Pemeriksaan golongan darah

Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu-waktu diperlukan apabila terjadi situasi kegawatdaruratan. Pemeriksaan dilakukan apabila ibu hamil belum diketahui golongan darahnya.

b. Pemeriksaan kadar Hemoglobin darah (Hb)

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil dilakukan minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan.

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil pada trimester kedua dilakukan atas indikasi.

c. Pemeriksaan protein dalam urin

Pemeriksaan protein dalam urin pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu indikator terjadinya pre-eklampsia pada ibu hamil.

d. Pemeriksaan kadar gula darah

Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes melitus harus dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilannya minimal sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan sekali pada trimester ketiga.

e. Pemeriksaan darah Malaria

Semua ibu hamil di daerah endemis Malaria (endemis sedang dan tinggi) dilakukan pemeriksaan darah Malaria dalam rangka skrining pada kontak pertama. Ibu hamil di daerah non endemis Malaria (endemis rendah) dilakukan pemeriksaan darah Malaria apabila ada indikasi.

f. Pemeriksaan tes Sifilis

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan di daerah dengan risiko tinggi dan ibu hamil yang diduga menderita sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan.

g. Pemeriksaan HIV Di daerah epidemi

HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.

h. Pemeriksaan BTA

Pemeriksaan BTA dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai menderita tuberkulosis sebagai pencegahan agar infeksi tuberkulosis tidak mempengaruhi kesehatan janin.

9. Tatalaksana / Penanganan Kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.

10. Temu Wicara (Konseling)

Temu wicara (konseling) dilakukan pada setiap kunjungan antenatal yang meliputi :

- a. Kesehatan ibu Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin ke tenaga kesehatan dan menganjurkan ibu hamil agar beristirahat yang cukup selama kehamilannya (sekitar 9-10 jam per hari) dan tidak bekerja berat.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan selama kehamilan misalnya mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun, menggosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur serta melakukan olahraga ringan.
- c. Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan Setiap ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dari keluarga terutama suami dalam kehamilannya. Suami, keluarga atau masyarakat perlu menyiapkan biaya persalinan, kebutuhan bayi, transportasi rujukan dan calon donor darah. Hal ini penting apabila terjadi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
- d. Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi Setiap ibu hamil diperkenalkan mengenal tanda-tanda bahaya baik selama kehamilan, persalinan, dan nifas misalnya perdarahan pada hamil muda

maupun hamil tua, keluar cairan berbau pada jalan lahir saat nifas, dsb. Mengenal tanda-tanda bahaya ini penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan.

- e. Asupan gizi seimbang Selama hamil, ibu dianjurkan untuk mendapatkan asupan makanan yang cukup dengan pola gizi yang seimbang karena hal ini penting untuk proses tumbuh kembang janin dan derajat kesehatan ibu. Misalnya ibu hamil disarankan minum tablet tambah darah secara rutin untuk mencegah anemia pada kehamilannya.
- f. Gejala penyakit menular dan tidak menular. Setiap ibu hamil harus tahu mengenai gejala-gejala penyakit menular dan penyakit tidak menular karena dapat mempengaruhi pada kesehatan ibu dan janinnya.
- g. Penawaran untuk melakukan tes HIV dan Konseling di daerah epidemi meluas dan terkonsentrasi atau ibu hamil dengan IMS dan TB di daerah epidemi rendah. Setiap ibu hamil ditawarkan untuk dilakukan tes HIV dan segera diberikan informasi mengenai resiko penularan HIV dari ibu ke janinnya. Apabila ibu hamil tersebut HIV positif maka dilakukan konseling Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

(PPIA). Bagi ibu hamil yang negatif diberikan penjelasan untuk menjaga tetap HIV negatif diberikan penjelasan untuk menjaga HIV negatif selama hamil, menyusui dan seterusnya.

- h. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI eksklusif Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayinya segera setelah bayi lahir karena ASI mengandung zat kekebalan tubuh yang penting untuk kesehatan bayi. Pemberian ASI dilanjutkan sampai bayi berusia 6 bulan
- i. KB Paska Persalinan Ibu hamil diberikan pengarahan tentang pentingnya ikut KB setelah persalinan untuk menjarangkan kehamilan dan agar ibu punya waktu merawat kesehatan diri sendiri, anak, dan keluarga.
- j. Imunisasi Setiap ibu hamil harus mempunyai status imunisasi (T) yang masih memberikan perlindungan untuk mencegah ibu dan bayi mengalami tetanus neonatorum. Setiap ibu hamil minimal mempunyai status imunisasi T2 agar terlindungi terhadap infeksi tetanus.
- k. Peningkatan kesehatan intelegensia pada kehamilan (Brain Booster) Untuk dapat meningkatkan intelegensia bayi yang akan dilahirkan, ibu hamil dianjurkan untuk

memberikan stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkit otak (brain booster) secara bersamaan pada periode kehamilan.

C. Jenis Pelayanan Antenatal Care

Pelayanan antenatal terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter, bidan dan perawat terlatih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan antenatal terpadu terdiri dari:

1. Anamnesa

Dalam memberikan pelayanan antenatal terpadu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan anamnesa, yaitu:

- a. Menanyakan keluhan atau masalah yang dirasakan oleh ibu saat ini.
- b. Menanyakan tanda-tanda penting yang terkait dengan masalah kehamilan dan penyakit yang kemungkinan diderita ibu hamil
- c. Menanyakan status kunjungan (baru atau lama), riwayat kehamilan yang sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya dan riwayat penyakit yang diderita ibu hamil.
- d. Menanyakan status imunisasi Tetanus ibu hamil
- e. Menanyakan jumlah tablet tambah darah yang dikonsumsi ibu hamil

- f. Menanyakan obat-obat yang dikonsumsi seperti: antihipertensi, diuretika, anti vomitus, antipiretika, antibiotika, obat TB dan sebagainya.
- g. Di daerah endemis malaria, tanyakan gejala malaria dan riwayat pemakaian obat malaria.
- h. Di daerah risiko tinggi IMS, tanyakan gejala IMS dan riwayat penyakit pada pasangannya. Informasi ini penting untuk langkah-langkah penanggulangan penyakit menular seksual.
- i. Menanyakan pola makan ibu selama hamil yang meliputi jumlah, frekuensi dan kualitas asupan makanan terkait dengan kandungan gizinya.
- j. Menanyakan kesiapan menghadapi persalinan dan menyikapi kemungkinan terjadinya komplikasi dalam kehamilan

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam pelayanan antenatal terpadu, meliputi berbagai jenis pemeriksaan termasuk menilai keadaan umum (fisik) dan psikologis (kejiwaan) ibu hamil.

Tabel 2.1 Jenis Pemeriksaan Antenatal Care Terpadu

No	Jenis Pemeriksaan	TM1	TM 2	TM 3
1	Keadaan umum	o	o	o
2	Suhu tubuh	o	o	o
3	Tekanan darah	o	o	o
4	Berat Badan	o	o	o

5	Lila	o		
6	TFU		o	o
7	Presentasi Janin		o	o
8	DJJ		o	o
9	Pemeriksaan Hb	o		o
10	Golongan Darah	o		
11	Protein Urin		*	*
12	Gula Darah / Reduksi	*	*	*
13	Darah Malaria	o*	*	*
14	BTA	*	*	*
15	IMS / Sifilis	*	*	*
16	Serologi HIV	o**	*	*
17	USG	*	*	*
Ket	o : Rutin 8 : khusus atas indikasi o* : di daerah endemis o** : Terkonfirmasi IMS dan TB			

3. Penanganan dan tindak lanjut Kasus

Berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya, dokter menegakkan diagnosa kerja atau diagnosa banding, sedangkan bidan/perawat dapat mengenali keadaan normal dan keadaan bermasalah/tidak normal pada ibu hamil.

Pada setiap kunjungan antenatal, semua pelayanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan dan penanganan yang diberikan serta rencana tindak-lanjutnya harus diinformasikan kepada ibu hamil dan suaminya. Jelaskan tanda-tanda bahaya

dimana ibu hamil harus segera datang untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan.

Apabila ditemukan kelainan atau keadaan tidak normal pada kunjungan antenatal, informasikan rencana tindak lanjut termasuk perlunya rujukan untuk penanganan kasus, pemeriksaan laboratorium/ penunjang, USG, konsultasi atau perawatan, dan juga jadwal kontrol berikutnya, apabila diharuskan datang lebih cepat.

Ibu hamil yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah ibu hamil yang mengalami segala bentuk tindak kekerasan yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terhadap korban kekerasan merupakan tempat dilaksanakannya pelayanan kepada korban kekerasan baik di rumah sakit umum pemerintah dan swasta termasuk rumah sakit POLRI secara komprehensif oleh multidisipliner dibawah satu atap (one stop services)

4. Pencatatan hasil pemeriksaan antenatal terpadu.

Pencatatan hasil pemeriksaan merupakan bagian dari standar pelayanan antenatal terpadu yang berkualitas. Setiap kali pemeriksaan, tenaga kesehatan wajib mencatat hasilnya pada rekam medis, Kartu Ibu dan Buku KIA.

Pada saat ini pencatatan hasil pemeriksaan antenatal masih sangat lemah, sehingga data-datanya tidak dapat dianalisa untuk peningkatan kualitas pelayanan antenatal. Dengan menerapkan pencatatan sebagai bagian dari standar pelayanan, maka kualitas pelayanan antenatal dapat ditingkatkan.

5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang Efektif

KIE yang efektif termasuk konseling merupakan bagian dari pelayanan antenatal terpadu yang diberikan sejak kontak pertama untuk membantu ibu hamil dalam mengatasi masalahnya.

Bab 3

Pemberdayaan Ibu Melalui Kelas Ibu Hamil

A. Konsep Ibu Hamil

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman, tentang kesehatan ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket kelas ibu hamil, yang terdiri atas buku KIA, lembar balik (*flip chart*), pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, pegangan fasilitator kelas ibu hamil, dan buku senam ibu hamil (Kemenkes RI, 2014).

Beberapa keuntungan kelas ibu hamil antara lain (Kemenkes RI, 2014) : Materi diberikan secara menyeluruh dan terencana sesuai dengan pedoman kelas ibu hamil yang memuat mengenai pemeriksaan

kehamilan agar ibu dan janin sehat, persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat, pencegah penyakit, komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat, perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal serta aktifitas fisik ibu hamil.

1. Materi lebih komperhensif sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam persiapan pelaksanaan kelas ibu hamil sebelum penyajian materi.
2. Dapat mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan penjelasan mengenai topik tertentu.
3. Waktu pembahasan materi menjadi efektif karena pola penyajian materi terstruktur dengan baik.
4. Ada interaksi antara petugas kesehatan dengan ibu hamil pada saat pembahasan materi dilaksanakan.
5. Dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
6. Dilakukan evaluasi terhadap petugas kesehatan dan ibu hamil dalam memberikan penyajian materi sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pembelajaran.

B. Tujuan, Sasaran dan Output Kelas Ibu Hamil

1. Tujuan Umum
Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat, persalinan

aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat, pencegahan penyakit fisik dan jiwa, gangguan gizi dan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, serta bayi sehat, perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal, serta aktivitas fisik ibu hamil (Kemenkes RI, 2014).

2. Tujuan Khusus

- a. Terjadinya interaksi dan berbagi pengalaman antara peserta (ibu hamil/suami/keluarga/dengan ibu hamil/suami/keluarga) dan antara ibu hamil/suami/keluarga dengan petugas kesehatan/bidan tentang pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat, persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat, pencegahan penyakit, komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat, perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal serta aktivitas fisik ibu hamil.
- b. Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu hamil tentang: Pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat (pengertian kehamilan, tanda-tanda kehamilan, keluhan yang sering dialami ibu hamil, perubahan fisik ibu hamil, perubahan emosional ibu hamil, pemeriksaan

kehamilan, pelayanan kesehatan pada ibu hamil, menjaga ibu dan janin sehat, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil, mitos/tabu, dan persiapan menghadapi persalinan.

- c. Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu hamil tentang: Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat (tanda-tanda awal persalinan, tanda-tanda persalinan, proses persalinan, inisiasi menyusui dini (IMD), KB pasca persalinan, pelayanan nifas, menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayi sehat, hal-hal yang harus dihindari ibu bersalin dan nifas)
- d. Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu hamil tentang: Pencegahan penyakit, komplikasi kehamilan agar ibu dan bayi sehat (penyakit malaria, gejala dan akibatnya, cara penularan malaria, cara pencegahan malaria, infeksi menular seksual (IMS), gejala umum, HIV dan AIDS, cara pencegahan HIV/AIDS pada ibu hamil, Kurang energi kronis (KEK), Anemia tanda bahaya pada kehamilan, tanda bahaya pada persalinan, tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas, dan sindroma pasca melahirkan).
- e. Perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal (tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, pelayanan neonatus

(6 jam – 28 hari), tanda bahaya pada bayi baru lahir, cacat bawaan, perawatan metode kangguru (PMK), posisi dan perlekatan menyusui yang benar, pemberian imunisasi, menjaga bayi agar sehat, hal-hal yang harus dihindari, mitos dan akta kelahiran)

3. Sasaran Kelas Ibu Hamil

Peserta ibu hamil sebaiknya semua ibu hamil yang ada di wilayah tersebut, dengan usia kehamilan 4-36 minggu, atau pada usia kehamilan 22-36 minggu untuk mengikuti kegiatan tambahan dalam kelas ibu hamil yaitu senam hamil. Pada usia kehamilan tersebut ibu sudah cukup kuat, tidak takut terjadi keguguran, dan efektif untuk mengikuti senam hamil. Jumlah peserta kelas ibu hamil maksimal sebanyak 10 orang setiap kelas. Suami/keluarga ikut serta minimal 1 kali pertemuan sehingga dapat mengikuti berbagai materi penting, misalnya materi tentang persiapan persalinan atau materi yang lain (Kemenkes RI, 2014).

4. Output / Luaran

- a. Adanya interaksi dan berbagi pengalaman antar peserta (ibu hamil dengan ibu hamil) dan ibu hamil dengan bidan/tenaga kesehatan tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan,

persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi, mitos/kepercayaan/adat istiadat setempat, penyakit menular dan akte kelahiran.

b. Adanya pemahaman, perubahan sikap dan perilaku ibu hamil tentang:

- 1) kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan (apakah kehamilan itu? perubahan tubuh selama kehamilan, keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya, apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil dan pengaturan gizi termasuk pemberian tablet tambah darah untuk penanggulangan anemia).
- 2) perawatan kehamilan (kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, hubungan suami istri selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, dan P4K (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi)).
- 3) persalinan (tanda-tanda persalinan, tanda bahaya persalinan, dan proses persalinan).
- 4) perawatan Nifas (apa saja yang dilakukan ibu nifas agar dapat menyusui eksklusif?, bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas, tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas).
- 5) KB pasca persalinan.

- 6) perawatan bayi baru lahir (perawatan bayi baru lahir, pemberian K1 injeksi, tanda bahaya bayi baru lahir, pengamatan perkembangan bayi/anak dan pemberian imunisasi pada bayi baru lahir).
- 7) mitos/kepercayaan/adat istiadat setempat yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.
- 8) penyakit menular (IMS, informasi dasar HIV-AIDS dan pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil).
- 9) akte kelahiran.

C. Konsep Pendidikan kesehatan untuk Ibu Hamil

Konsep pendidikan kesehatan ibu hamil melalui kelas ibu hamil adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dalam menjaga kesehatannya serta tumbuh kembang janin selama masa kehamilan. Kelas ibu hamil ini biasanya diselenggarakan oleh rumah sakit, puskesmas, atau lembaga kesehatan lainnya dan dilakukan secara kelompok atau individu. Konsep utamanya adalah memberikan pendidikan berbasis informasi yang bermanfaat agar ibu hamil lebih siap dalam

menghadapi proses kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi setelah lahir.

Berikut adalah beberapa elemen penting dari konsep pendidikan kesehatan ibu hamil melalui kelas ibu hamil:

1. Pendidikan Gizi dan Nutrisi

Mengajarkan ibu hamil tentang pentingnya pola makan sehat, pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan, serta cara menghindari makanan yang dapat berisiko bagi kesehatan ibu dan janin.

2. Perubahan Fisiologis dan Psikologis Kehamilan

Memberikan pemahaman mengenai perubahan fisik dan psikologis yang dialami oleh ibu hamil, serta cara untuk menghadapinya, misalnya mengelola stres, kecemasan, atau perubahan suasana hati.

3. Pemantauan Kehamilan

Mengajarkan cara ibu hamil melakukan pemantauan terhadap kesehatan diri dan janin, seperti cara menghitung gerakan janin, mengenali tanda-tanda komplikasi, serta kapan harus menghubungi tenaga medis.

4. Persiapan Persalinan

Memberikan informasi tentang proses persalinan, tanda-tanda persalinan, teknik pernapasan saat kontraksi, dan berbagai metode persalinan yang

mungkin ditemui (misalnya, persalinan normal, caesar, atau air).

5. Perawatan Pasca Persalinan dan Bayi Baru Lahir
Memberikan pengetahuan mengenai perawatan diri pasca persalinan, seperti pemulihan fisik dan mental ibu, serta perawatan bayi yang baru lahir, termasuk menyusui, pemberian ASI, dan vaksinasi.
6. Kesehatan Mental Ibu Hamil
Membahas pentingnya menjaga kesehatan mental selama kehamilan, dan mengidentifikasi tanda-tanda gangguan kesehatan mental seperti depresi pasca melahirkan, serta cara-cara untuk mendapatkan dukungan.
7. Penyuluhan tentang Penyakit Tertentu dan Pencegahannya
Memberikan informasi tentang penyakit yang sering dialami ibu hamil, seperti preeklamsia, diabetes gestasional, anemia, dan cara-cara pencegahannya.
8. Latihan Fisik dan Pernafasan
Mengajarkan ibu hamil teknik pernapasan dan latihan fisik ringan yang dapat membantu memperlancar proses persalinan dan meningkatkan kesejahteraan tubuh ibu hamil.

Kelas ibu hamil juga sering kali menjadi sarana untuk menciptakan dukungan sosial di antara ibu hamil,

membangun rasa percaya diri, dan memotivasi mereka untuk menjalani kehamilan dengan lebih sehat. Dengan adanya kelas ini, ibu hamil dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi proses kehamilan dan persalinan.

D. Materi Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

1. Materi Pertemuan Kelas Pertama
 - a) Penjelasan umum kelas ibu hamil dan pengenalan peserta
 - b) Evaluasi awal materi pertemuan I
 - c) Materi kelas ibu hamil (pertemuan I)
 - 1) Kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan
 - Apa kehamilan itu?
 - Perubahan tubuh ibu hamil
 - Keluhan umum dan penanganan
 - Pengaturan gizi termasuk pemberian TTD untuk anemia
 - 2) Perawatan Kehamilan
 - Kesiapan psikologis menghadapi kehamilan
 - Hubungan suami istri selama kehamilan
 - Obat yang diperbolehkan selama hamil
 - Tanda bahaya kehamilan

- Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (p4k)
 - d) Evaluasi harian dan evaluasi akhir (posttest) materi pertemuan I
 - e) Kesimpulan
 - f) Senam ibu hamil
2. Materi Pertemuan Kedua
- a) Review materi pertemuan I dan hasil evaluasi
 - b) Evaluasi awal (pretest materi pertemuan II)
 - c) Materi kelas ibu hamil
 - 1) Persalinan
 - Tanda persalinan
 - Tanda bahaya pada persalinan
 - Proses persalinan
 - Inisiasi menyusui dini (IMD)
 - 2) Perawatan nifas
 - Apa saja yang dilakukan ibu nifas agar dapat menyusui eksklusif
 - Bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas
 - Tanda bahaya penyakit ibu nifas
 - KB pasca salin
 - d) Evaluasi harian hari ke-II dan evaluasi akhir materi pertemuan II
 - e) Kesimpulan
 - f) Senam ibu hamil

3. Materi pertemuan ketiga

- a) Review materi pertemuan II dan hasil evaluasi
- b) Evaluasi awal (prates) materi pertemuan III
- c) Materi kelas ibu hamil (pertemuan III)
 - 1) Perawatan bayi
 - Perawatan bayi baru lahir
 - Pemberian vitamin k1 injeksi pada BBL
 - Tanda bahaya BBL
 - Pengamatan perkembangan bayi/anak
 - Pemberian imunisasi pada BBL
 - 2) Mitos
Penggalian dan penelusuran mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak
 - 3) Penyakit menular
 - Infeksi menular seksual (IMS)
 - Informasi dasar HIV/AIDS
 - Pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil
 - 4) Akte kelahiran
- d) Evaluasi harian hari ke-III dan evaluasi akhir
- e) Kesimpulan
- f) Senam ibu hamil

Bab 4

Pengembangan Teknologi dalam Pendidikan Kesehatan Ibu Hamil

A. Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Akses Kesehatan Ibu Hamil

Teknologi informasi kesehatan dan inovasi digital untuk sistem pembelajaran kesehatan dan perawatan nasional. Teknologi informasi kesehatan dapat mendukung pengembangan sistem kesehatan dan perawatan pembelajaran nasional, yang dapat didefinisikan sebagai sistem kesehatan dan perawatan yang terus menggunakan infrastruktur berbasis data untuk mendukung kebijakan dan perencanaan, kesehatan masyarakat, dan personalisasi perawatan.

Android merupakan sistem operasi seluler yang berkembang pesat di smartphones saat ini, mendukung pengembangan ide dan inovasi aplikasi baru untuk

menambah fungsionalitas system. Peluang ini, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat melalui sistem android (Agustha & Fachrizal, 2017) agar mudah mendapatkan informasi dan layanan kesehatan.

Tujuan dari perancangan aplikasi android ini adalah agar mempermudah ibu hamil dalam mencari tau kebutuhan kehamilan dalam satu wadah atau aplikasi juga meningkatkan minat pengguna dalam pentingnya menjaga kehamilan serta melakukan aktivitas anjuran semasa hamil dengan maksimal meskipun dari rumah.

Di era maraknya teknologi internet seperti saat ini, dimana semua sudah serba digital dan online maka sangat mungkin melakukan pemasaran sosial melalui medium digital, media sosial. Apalagi jika melihat penetrasi internet di Indonesia saat ini, lebih dari 170 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari jumlah total penduduk Indonesia kini telah terhubung dengan internet (Indonesia, 2018). Data We Are Social (2019) melaporkan bahwa 92% pengguna internet di Indonesia berpartisipasi aktif dalam penggunaan media sosial (Websindo). Bahkan jumlah waktu yang dialokasikan untuk mengakses media sosial juga mencapai 3 jam 26 menit per hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menggemari media sosial (Elwani, 2020)

Kurangnya pengetahuan saat masa kehamilan, membuat ibu hamil menghiraukan timbulnya gejala-gejala penyakit berbahaya tertentu yang secara tidak langsung menjadi penyebab kematian ibu hamil (Aji dkk., 2018). Kondisi ini mungkin disebabkan rendahnya tingkat komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu hamil sehingga pendidikan kesehatan sangatlah penting dalam menunjang program kesehatan (Nur dkk., 2018).

Kajian penelitian sebelumnya, kendala komunikasi terapeutik antara bidan dengan ibu hamil dipengaruhi adanya hambatan bahasa, budaya dan psikologis (Prasanti & Fuady, 2017). Salah satu terobosan yakni pembentukan kelas ibu hamil sebagai sarana belajar bersama agar ibu hamil mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan kehamilan, namun tingkat partisipasinya masih rendah (Baroroh dkk., 2017).

Media komunikasi kesehatan kehamilan dan persalinan yang digunakan oleh ibu millennial adalah media yang didukung oleh teknologi internet untuk memudahkan terjadinya interaksi melalui komputer dan smartphone seperti Instagram dan group whatsapp ibu hamil. Media tersebut digunakan oleh ibu millennial karena informasinya dapat diakses dimanapun dan kapan pun. Para ibu millennial tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk datang menemui bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Para ibu millennial juga tetap mempertimbangkan kredibilitas dari sumber informan

tersebut dengan cara memilih media sosial yang dimiliki oleh bidan atau pun tenaga medis yang terpercaya dan juga sesama ibu millennial yang sudah memiliki pengalaman yang secara sukarela berbagi informasi. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan internet diharapkan informasi yang benar dan terpercaya dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan bayi (Sarasati, 2020).

Layanan Kesehatan digital hadir di masyarakat, dengan ragam pilihan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kesehatan Masyarakat. Salah satunya, melalui layanan kesehatan berbasis seluler berpotensi dan bermanfaat meningkat praktik antenatal care secara positif dalam mempengaruhi perilaku ibu hamil.

B. Keunggulan Aplikasi Android dalam Pendidikan Kesehatan

Android merupakan salah satu sistem operasi dalam smartphone yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan smartphone berbasis android memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem operasi yang lain, diantaranya harga yang relatif lebih terjangkau, memiliki berbagai macam perangkat dan fitur yang hanya tersedia di android, dan memungkinkan pengguna untuk memilih tingkat kostumisasi sendiri

terkait aplikasi-aplikasi yang tersedia didalamnya (Sahani, 2017).

Media pembelajaran menggunakan aplikasi berbasis android memiliki kelebihan dan manfaat, diantaranya mudah dalam mengakses berbagai informasi dengan mudah dan cepat, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, memiliki tampilan yang menarik, mempermudah akses informasi dan menambah wawasan termasuk mengenai informasi kesehatan (Juraman, 2014).

Penggunaan aplikasi Android untuk edukasi kesehatan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Aplikasi Android dapat menjadi media yang mudah digunakan untuk mengakses informasi kesehatan sebagai menunjang peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat terkait Kesehatan.

Aplikasi Android dalam pendidikan kesehatan ibu hamil memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai kesehatan mereka serta perkembangan janin. Berikut adalah beberapa keunggulan utama aplikasi Android dalam pendidikan kesehatan ibu hamil:

1. Aksesibilitas yang Mudah

Aplikasi Android dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ibu hamil memiliki smartphone

dengan koneksi internet. Hal ini memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, yang sangat penting mengingat kesibukan ibu hamil dan keterbatasan jadwal.

2. **Penyampaian Informasi yang Interaktif dan Menarik**
Aplikasi dapat menyajikan materi pendidikan dalam bentuk yang lebih interaktif, seperti video, animasi, kuis, dan grafik. Ini membantu ibu hamil untuk lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting mengenai kesehatan mereka, cara merawat kehamilan, dan apa yang harus dilakukan selama proses persalinan.
3. **Personalisasi Pengalaman Pengguna**
Banyak aplikasi Android yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal dan pengingat sesuai dengan kebutuhan pribadi, seperti pengingat untuk memeriksa kesehatan, mengonsumsi suplemen atau vitamin, melakukan olahraga ringan, atau melakukan pemeriksaan rutin. Aplikasi yang dapat menyesuaikan dengan fase kehamilan (trimester) juga memungkinkan ibu hamil mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tahap kehamilan mereka.
4. **Pemantauan Kehamilan Secara Mandiri**

Aplikasi Android memungkinkan ibu hamil untuk memantau kondisi kehamilan mereka secara mandiri, seperti menghitung gerakan janin, mengukur berat badan, atau mencatat gejala atau keluhan yang dialami. Beberapa aplikasi juga memiliki fitur untuk mencatat tekanan darah, kadar gula darah, dan tanda-tanda penting lainnya untuk membantu ibu hamil memantau kesehatannya.

5. Pendidikan Berbasis Data dan Bukti

Aplikasi pendidikan kesehatan ibu hamil sering kali dirancang dengan basis data ilmiah yang akurat, berdasarkan pedoman kesehatan yang direkomendasikan oleh organisasi medis global. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada ibu hamil tidak hanya praktis, tetapi juga valid dan terpercaya.

6. Interaksi dengan Tenaga Kesehatan

Beberapa aplikasi memungkinkan komunikasi langsung dengan tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan, melalui fitur chat atau video call. Hal ini memberikan kesempatan bagi ibu hamil untuk berkonsultasi jika mereka merasa khawatir atau memiliki pertanyaan terkait kesehatan mereka atau janin.

7. Penyuluhan dan Edukasi Melalui Notifikasi

Aplikasi dapat mengirimkan notifikasi atau pengingat rutin yang berisi tips-tips kesehatan, artikel, atau pengingat untuk pemeriksaan kehamilan dan vaksinasi. Fitur ini membantu ibu hamil tetap mendapatkan informasi terbaru dan relevan sepanjang kehamilan mereka.

8. Penyediaan Dukungan Psikologis

Beberapa aplikasi juga menyediakan fitur untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil, seperti meditasi, latihan relaksasi, atau forum komunitas untuk berbagi pengalaman dengan ibu hamil lainnya. Ini penting karena kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil.

9. Kemudahan dalam Melacak Perkembangan Janin

Aplikasi Android memungkinkan ibu hamil untuk melacak perkembangan janin mereka dengan mudah, seperti menghitung usia kehamilan, mengetahui ukuran janin, serta membaca tentang tahap perkembangan organ-organ janin yang berbeda setiap minggunya.

10. Efisiensi dan Biaya yang Lebih Terjangkau

Dibandingkan dengan biaya mengikuti kelas pendidikan atau konsultasi langsung dengan tenaga medis, aplikasi Android dapat menawarkan pendidikan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau, bahkan sering kali gratis. Ini

membuatnya menjadi solusi yang hemat biaya bagi ibu hamil yang ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat.

11. Privasi dan Kenyamanan

Menggunakan aplikasi Android memberi ibu hamil kesempatan untuk belajar tentang kehamilan mereka dengan cara yang lebih pribadi dan nyaman. Mereka bisa membaca informasi atau mencari jawaban tanpa merasa canggung atau malu, serta menjaga privasi terkait kondisi kesehatan atau masalah pribadi.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, aplikasi Android menjadi sarana yang sangat potensial untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan ibu hamil, serta mendorong mereka untuk menjalani kehamilan yang lebih sehat dan aman.

Bab 5

Dampak Pengembangan Aplikasi Android terhadap Kualitas Kesehatan Ibu Hamil

A. Dampak Positif

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil Kemenkes tahun 2020 menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan Kelas Ibu Hamil berjalan dengan baik, berkualitas dan sesuai dengan rencana. pengawasan dilakukan dalam rangka melihat perkembangan dan pencapaian, serta masalah dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, hasil monitoring dapat dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kelas ibu hamil selanjutnya. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Monitoring

di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Mengingat mudah dan canggihnya teknologi di era globalisasi ini, seharusnya pengawasan semakin mudah dilakukan. Jika para petugas pelaksana tingkat atas tidak bisa mengawasi petugas pelaksana tingkat bawah dengan cara observasi langsung, maka sebaiknya dilakukan melalui telepon atau melalui laporan khusus program kelas ibu hamil. Sebagaimana metode pengawasan yang dikemukakan Azwar (1996) bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah melalui laporan khusus, observasi personal dan alat elektronik.

Selain memberikan manfaat langsung kelas ibu hamil berbasis android ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan. Dalam konteks pelayanan kebidanan, teknologi dapat mempercepat distribusi informasi dan memberikan akses yang lebih luas kepada ibu hamil, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang kesulitan untuk mengikuti kelas secara fisik. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan ibu hamil untuk mempelajari materi tentang kehamilan dan persalinan kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kenyamanan mereka.

Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan, seperti bidan atau tenaga medis lainnya, untuk memantau perkembangan peserta kelas secara lebih efisien. Fasilitator bisa mengakses data secara real-time, memantau kemajuan peserta, dan memberikan bimbingan lebih lanjut jika diperlukan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi ibu hamil dalam memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendukung tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih terarah dan efektif.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada keterlibatan dan komitmen para fasilitator dalam menjalankan kelas. Meskipun aplikasi menawarkan banyak kemudahan, peran aktif dari fasilitator tetap sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dipahami dengan baik dan ibu hamil merasa didukung dalam perjalanan kehamilannya. Interaksi langsung, meskipun dilakukan secara virtual atau dalam bentuk kelompok belajar, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah keberagaman latar belakang peserta, baik dari segi usia kehamilan, pengalaman, hingga kondisi kesehatan masing-masing.

Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan dalam kelas agar materi yang diberikan tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh peserta. Dalam hal ini, penggunaan metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran mandiri dengan sesi interaktif, bisa menjadi solusi untuk mengakomodasi kebutuhan peserta yang beragam.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan serta kesehatan ibu hamil. Selain pengawasan langsung, metode pengawasan melalui teknologi, seperti penggunaan aplikasi atau laporan elektronik, juga dapat mempercepat proses evaluasi dan memperbaiki setiap kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kelas.

Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kesehatan juga sangat penting untuk mendukung kelancaran program ini. Dengan adanya pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan, mereka dapat lebih siap dalam memfasilitasi kelas ibu hamil dan memberikan layanan yang berkualitas. SDM yang terlatih akan lebih memahami

cara menggunakan aplikasi ini secara efektif, serta mampu memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi ibu hamil.

Secara keseluruhan, aplikasi kelas ibu hamil ini bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah menuju peningkatan akses terhadap pendidikan kesehatan yang lebih luas dan merata. Melalui aplikasi ini, diharapkan pengetahuan ibu hamil akan bertambah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terinformasi dengan baik, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan perawatan ibu serta bayi.

B. Dampak Negatif

Kelas ibu hamil berbasis Android merupakan inovasi dalam dunia kesehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil melalui teknologi digital. Dengan adanya aplikasi ini, ibu hamil dapat mengakses informasi kesehatan dengan lebih mudah, mengikuti kelas kehamilan secara fleksibel, serta mendapatkan berbagai fitur pendukung lainnya. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan kelas ibu hamil berbasis Android juga tidak

terlepas dari berbagai tantangan dan dampak negatif yang perlu diantisipasi. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya.

1. Kesenjangan Akses dan Literasi Digital

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kelas ibu hamil berbasis Android adalah tidak semua ibu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi, masih banyak ibu hamil yang tidak memiliki smartphone atau akses internet yang stabil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan edukasi, di mana hanya ibu dengan fasilitas memadai yang bisa menikmati manfaat aplikasi secara optimal.

Selain itu, literasi digital juga menjadi kendala. Tidak semua ibu hamil, terutama yang berusia lebih tua atau yang belum terbiasa menggunakan teknologi, dapat dengan mudah memahami cara kerja aplikasi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, mengikuti kelas daring, atau menggunakan fitur aplikasi dengan benar.

Solusi:

- a. Menyediakan panduan penggunaan aplikasi dalam bentuk video atau tutorial sederhana yang mudah diakses dan dipahami.
 - b. Menggabungkan kelas daring dengan sesi tatap muka atau konsultasi langsung bagi ibu yang mengalami kesulitan teknologi.
 - c. Mengupayakan kerja sama dengan pemerintah atau pihak terkait untuk menyediakan fasilitas akses internet di daerah terpencil.
2. Berkurangnya Interaksi Tatap Muka dan Dukungan Sosial

Kelas ibu hamil secara konvensional bukan hanya tempat untuk mendapatkan informasi kesehatan, tetapi juga menjadi ruang bagi para ibu untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta membangun komunitas yang dapat membantu mereka menjalani kehamilan dengan lebih nyaman.

Dengan beralihnya kelas ibu hamil ke platform digital, interaksi langsung antara ibu hamil, tenaga kesehatan, dan sesama peserta menjadi terbatas. Rasa kebersamaan dan dukungan sosial yang biasanya diperoleh dari kelas offline bisa berkurang, sehingga ada kemungkinan ibu hamil merasa lebih kesepian atau kurang termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran.

Solusi :

- a. Menyediakan fitur forum diskusi atau grup komunitas di dalam aplikasi untuk mendorong interaksi antaribu hamil.
 - b. Mengadakan sesi live video atau webinar dengan tenaga kesehatan agar peserta tetap bisa berinteraksi langsung.
 - c. Mendorong ibu hamil untuk tetap melakukan pertemuan offline dalam komunitas setempat jika memungkinkan.
3. Ketergantungan pada Teknologi dan Potensi Gangguan Teknis

Keberhasilan kelas ibu hamil berbasis Android sangat bergantung pada stabilitas teknologi yang digunakan. Jika aplikasi mengalami gangguan teknis, seperti bug, server down, atau kesalahan sistem, maka akses ibu hamil terhadap informasi dan layanan edukasi dapat terhambat. Selain itu, tidak semua ibu hamil memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi yang mampu menjalankan aplikasi dengan lancar.

Ketergantungan pada teknologi juga dapat menyebabkan ibu hamil kurang aktif mencari informasi dari sumber lain, seperti membaca buku kehamilan atau berkonsultasi langsung dengan

tenaga medis. Mereka mungkin merasa cukup hanya dengan informasi yang tersedia di aplikasi, tanpa menyaring atau memverifikasi lebih lanjut.

Solusi :

- a. Mengembangkan aplikasi yang ringan dan bisa digunakan di berbagai jenis perangkat, termasuk smartphone dengan spesifikasi rendah.
 - b. Memastikan adanya layanan bantuan teknis yang responsif bagi pengguna yang mengalami kendala teknis.
 - c. Mengingatkan pengguna untuk tetap memverifikasi informasi dengan tenaga kesehatan dan tidak hanya mengandalkan aplikasi.
4. Risiko Informasi yang Tidak Akurat atau Salah Tafsir
- Keakuratan informasi dalam aplikasi kesehatan sangat krusial, terutama karena menyangkut kondisi ibu hamil yang memerlukan perhatian khusus. Jika informasi yang diberikan dalam aplikasi tidak berdasarkan sumber medis yang valid atau tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, maka bisa berisiko menyesatkan pengguna.

Selain itu, meskipun informasi dalam aplikasi sudah benar, ibu hamil tetap berisiko salah menafsirkan isi materi jika tidak ada bimbingan langsung. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam penerapan informasi, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan janin.

Solusi :

- a. Memastikan bahwa semua konten aplikasi dibuat dan diverifikasi oleh tenaga kesehatan profesional, seperti dokter kandungan dan bidan.
 - b. Memberikan sumber referensi medis yang jelas dan terpercaya di setiap materi yang disajikan dalam aplikasi.
 - c. Menyediakan fitur konsultasi langsung dengan tenaga medis untuk memastikan pemahaman yang benar atas informasi yang diberikan.
5. Ancaman terhadap Keamanan dan Privasi Data Pengguna

Dalam aplikasi kesehatan, data pribadi ibu hamil, seperti riwayat kehamilan, usia kehamilan, dan data medis lainnya, sering kali dikumpulkan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Namun, jika tidak ada sistem keamanan data yang kuat, informasi ini bisa rentan terhadap kebocoran

atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kebocoran data pribadi tidak hanya berisiko terhadap privasi pengguna, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial, seperti iklan tidak diinginkan atau penipuan yang menyasar ibu hamil.

Solusi:

- a. Menggunakan sistem enkripsi dan perlindungan data yang sesuai dengan standar keamanan digital.
 - b. Memberikan kebijakan privasi yang transparan dan memastikan pengguna memahami bagaimana data mereka digunakan.
 - c. Menghindari pengumpulan data yang tidak perlu dan hanya menyimpan informasi yang benar-benar diperlukan untuk layanan aplikasi.
6. Kurangnya Motivasi dan Disiplin dalam Mengikuti Kelas

Kelas ibu hamil berbasis Android memberikan fleksibilitas bagi ibu hamil untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, tanpa jadwal yang ketat dan interaksi langsung dengan instruktur, beberapa ibu hamil mungkin kehilangan motivasi untuk mengikuti kelas secara rutin. Mereka mungkin menunda atau bahkan melewatkan materi

yang penting, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kurangnya kesiapan mereka dalam menghadapi persalinan dan perawatan bayi.

Solusi:

- a. Menyediakan fitur pengingat dan pencatatan progres belajar agar ibu hamil tetap termotivasi untuk menyelesaikan materi.
- b. Mengadakan sesi evaluasi atau kuis untuk memastikan pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari.
- c. Melibatkan pasangan atau keluarga dalam penggunaan aplikasi agar mereka dapat mendukung ibu hamil dalam mengikuti kelas secara konsisten.

Bab 6

Penutup

Buku ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, khususnya pada masa kehamilan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang besar untuk mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan ibu hamil. Buku ini telah mengulas bagaimana pemanfaatan aplikasi Android dapat menjadi salah satu solusi inovatif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap kesehatan mereka dan janin yang dikandung.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kesehatan ini dikenal dengan istilah digital health atau seringnya juga disebut telekesehatan (telehealth) yang banyak membawa keuntungan seperti pertukaran informasi medis antara pasien dengan tenaga kesehatan, layanan kesehatan dalam rangka diagnosis differential, akses kesehatan lebih efisien dan cost effective (Sunjaya, 2019). Dengan demikian, perlu dilakukan pembuatan aplikasi Kesehatan ibu hamil

sebagai upaya untuk membantu mengurangi angka kematian ibu hamil.

Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, menarik, dan relevan, aplikasi berbasis Android memiliki potensi besar untuk menjadi pendamping ibu hamil dalam perjalanan kehamilan mereka. Melalui penelitian dan pengalaman yang diuraikan dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami manfaat, tantangan, dan implementasi teknologi ini dalam konteks peningkatan layanan kesehatan ibu hamil.

Layanan Kesehatan digital hadir di masyarakat, dengan ragam pilihan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kesehatan masyarakat (Indriyanti & Wibowo, 2020). Salah satunya, melalui layanan kesehatan berbasis seluler berpotensi dan bermanfaat meningkat praktik antenatal care secara positif dalam mempengaruhi perilaku ibu hamil (Selvia & Ernawati, 2019). Android merupakan sistem operasi seluler yang berkembang pesat di smartphones saat ini, mendukung pengembangan ide dan inovasi aplikasi baru untuk menambah fungsionalitas sistem (Sarumaha dkk., 2020). Peluang ini, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat melalui sistem android agar mudah mendapatkan informasi dan layanan kesehatan.

Aplikasi E-Pregnancy untuk kelas ibu hamil sangat baik sebagai alat teknologi yang cocok untuk menambah informasi tentang kehamilan dan persalinan secara online. Terdapat perbedaan pengetahuan dan sikap yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi berbasis android kelas ibu hamil pada responden kelas eksperimen.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, peneliti, pembuat kebijakan, pengembang aplikasi, dan masyarakat luas. Selain itu, semoga buku ini juga dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam bidang kesehatan berbasis teknologi, khususnya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya menciptakan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Adefunke, E. S., & Oyetola, S. O. (2013). Health Information Need And Information Sources Of Pregnant Women In Ogbomoso Metropolis, Oyo State, Nigeria. Library Philosophy and Practice.
- Anasari T. (2013). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Melakukan Senam Hamil Pada Kelas Ibu Hamil. Jurnal Publikasi Kebidanan.
- Apriyani, M. Q. A. (2014). *Perancangan Aplikasi Kunjungan Kehamilan Berbasis Android*. Politeknik Negeri Batam.
- Armini, N. W., Sriasih, N. G. K., & Marhaeni, G. A. (2017). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita & Anak Prasekolah*. ANDI.
- Dinas Kesehatan Kota Cimahi. (2017). *Profil Kesehatan Kota Cimahi*.
- Ida, A. C. Manuaba. (2013). *Ilmu Kandungan, Penyakit Kandungan, Dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. EGC.
- Indrayani, D. M. E. . (2013). *Asuhan Persalinan dan bayi Baru Lahir*. CV. Trans Info Media.
- Indriyanti, E. R., & Wibowo, S. (2020). Bisnis Kesehatan Berbasis Digital : Intensi Penggunaan Aplikasi digital halodoc
- JNPK-KR. (2017). *Asuhan Persalinan Normal & Inisiasi Menyusui Dini*. Depkes RI.
- Kemenkes RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar*.Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2020). *Buku KIA Revisi 2020 Lengkap*. Kemenkes,RI.

- Kemenkes RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2017*.
Kemenkes RI.
- Lestari T. A., Susanti A., dan Fathunikmah. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Mengikuti Kelas Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Jurnal Ibu Dan Anak*. Vol: 6, No: 2.
- Mahdiyah D., Hakim A. R., dan Susilawati E. 2017. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Hamil Tentang Kelas Ibu Hmail Di Desa Kertak Hanyar II Wilayah Puskesmas Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2016. *Dinas Kesehatan*. Vol: 8, No 1.
- Marmi. (2016). *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Pustaka Pelajar
- Mohamad, R. W. (2021). Pemanfaatan System Informasi Mobile Bagi Kesehatan Ibu Hamil dan Anak. *Jambura Nursing Journal*, 32-38.
- Nasution R. S., dan Harahap H. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil. *Artikel Penelitian*. Vol. 10, No 1.
- Nooatmodjo S. (2007). *Promosi kesehatan & ilmu perilaku*. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ogunmodede, T.,
- Perpustakaan Nasional RI. (2015). *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*.
- Prasanti D, I. S. (2022). *Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem E-Health Alodokter*.

- Pratama, A., Sulistiowati, & Maulana, Y. M. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Ibu Berdasarkan SPM. *Jurnal Sistem informasi dan Komputer Akuntansi (JSIKA)*, 1-10
- Purwadi LK, K. I. (2016). *Kemampuan Literasi Informasi Ibu Hamil Dalam Persiapan Persalinan Di Kecamatan Wonosobo*.
- Putri, Mutiara, I., & Ismiyatun, N. (2020). Deteksi Dini Kehamilan Beresiko. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 40–51
- Risneni, dan Yenie H. 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kehadiran Ibu Hamil Pada Kelas Ibu Di Satu Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Keperawatan*. Vol: XIII, No.1
- Rusdiana, L. (2018). *Aplikasi Riwayat Konseling Kehamilan Untuk Ibu Hamil Berbasis Mobile Android*.
- Selvia, A., & Ernawati, D. (2019). Manfaat dan Kegunaan Aplikasi Berbasis Seluler sebagai Media Informasi dalam Kehamilan : Review Artikel. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2(2), 76.
- Septiani R. 2013. Pengetahuan, Sikap Ibu Hamil Dan Dukungan Suami Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Metro Lampung. *Jurnal Kesehatan*. Vol. IV, No: 2.
- Sunjaya, A. P. (2019). Potensi, Aplikasi dan Perkembangan Digital Health di Indonesia. *Journal of Indonesian Medical Association*, 69
- Tahir, Suriani. (2021). *Faktor Determinan Ketuban Pecah Dini*. Media Sains Indonesia.
- Tamrin, T., & Ma"arif, S. (2020). Android Base Rapid Application

Development for Learning Yanbu " a. Journal of Applied Intelligent System, 5(2), 91–97.

WHO. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.

Widiantari N. (2015). Hubungan Karakteristik dan Dukungan Sosial Suami dengan Partisipasi Ibu Mengikuti Kelas Ibu Hamil di Kota Denpasar. Tesis. Universitas Udayana Bali.

Yuliani DR, Saragih E, Astuti A, Ani WM, Muyassaroh Y, Nardina EA, Dewi RK, et al. (2021). *Asuhan Kehamilan*. Yayasan Kita Menulis.

Yusmaharani. 2018. Hubungan Dukungan Suami Dengan Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. Jurnal Kesmas Volume 1, No 1

Glosarium

A

Anamnesa : Proses pengumpulan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. Dalam konteks medis, anamnesa dilakukan untuk memahami keluhan, gejala, riwayat penyakit, dan faktor risiko yang dapat membantu dalam proses diagnosis dan perencanaan pengobatan.

Android : Sistem operasi perangkat mobile

Antenatal Care : Perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan

B

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) : Kondisi ketika bayi yang baru lahir memiliki berat badan yang lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 2.500 gram, terlepas dari usia kehamilannya.

C

CPD (Cephalo Pelvic Disproportion) : adalah kondisi yang terjadi ketika ukuran kepala bayi terlalu besar atau panggul ibu terlalu sempit untuk memungkinkan kelahiran normal.

D

Diagnosis : proses identifikasi penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala, tanda-tanda klinis, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil laboratorium dan diagnostik lainnya.

E

Efisiensi : Tingkat kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Eklampsia : Kondisi medis yang berbahaya selama kehamilan yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi setelah preeklampsia, yaitu kondisi hipertensi (tekanan darah tinggi) yang disertai dengan adanya protein dalam urine.

F

Flipchart : Alat bantu visual yang digunakan dalam presentasi atau pengajaran.

I

IMD (Inisiasi Menyusu Dini) : Proses pemberian ASI pertama kepada bayi yang dilakukan sesegera mungkin setelah kelahiran.

IMS (Infeksi Menular Seksual) : Infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit.

Intelegensi : Kemampuan untuk belajar, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan dalam berbagai situasi.

K

Kontrasepsi : Metode atau cara yang digunakan untuk mencegah kehamilan.

Komplikasi : Masalah kesehatan atau kondisi yang muncul sebagai akibat dari penyakit, prosedur medis, atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya

P

PMK (Perawatan Metode Kangguru) : Teknik perawatan bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang melibatkan kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi.

Preeklampsia : Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah tinggi (hipertensi) dan adanya protein dalam urine setelah usia kehamilan 20 minggu.

Portabilitas : Kemampuan suatu sistem, perangkat, atau aplikasi untuk digunakan atau dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa kehilangan fungsinya.

T

Telemedicine : Penggunaan teknologi komunikasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi khusus, untuk memberikan layanan medis atau konsultasi jarak jauh.

Profil Penulis



Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.

Menyelesaikan pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKes A. Yani Cimahi tahun 2008, menyelesaikan S2 Manajemen Kesehatan di IMNI Jakarta tahun 2010, menyelesaikan S2 Kebidanan di UNPAD tahun 2015 dan Program Doktorat di Lincoln University College Malaysia pada tahun 2024. Penulis mengawali karirnya sebagai bidan pelaksana, Kepala ruangan Kebidanan dan Supervisor di RS Rajawali dari tahun 1997-2012. Sejak tahun 2008 bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali dan jabatan terakhir sampai saat ini sebagai Dekan Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Rajawali. Saat ini penulis aktif dalam beberapa kegiatan penulisan buku ajar asuhan kebidanan, konselor Kesehatan ibu dan anak juga aktif praktik mandiri bidan di Kota Cimahi. Penulis juga aktif melakukan penelitian serta hasilnya sudah dipublikasikan ke jurnal yang bereputasi SINTA bahkan ada publikasi Internasional Scopus. Penulis memiliki harapan agar semua lulusan bidan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berdaya saing nasional dan internasional, memiliki nilai dan kreatifitas serta inovasi tinggi dalam mengembangkan pelayanan kebidanan. Semoga Allah SWT memudahkan setiap prosesnya. Aamiin Yaa Robbalalamiin. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: ernihernawatie@gmail.com. Penulis juga aktif menulis di platfrom dengan karyanya yang berjudul Buku Ajar Kegawat Daruratan Maternal Neonatal, penulis memberi kata-kata motivasi " Dengan melayani dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitarmu menjadikan kamu seorang Bidan yang profesional dan dapat diandalkan."

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengulas pengembangan kelas ibu hamil yang memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi untuk memberikan informasi dan layanan pendidikan kepada ibu hamil secara lebih efektif dan efisien. Dalam era digital, teknologi telah merambah berbagai sektor, termasuk dunia kesehatan. Dengan menggunakan aplikasi mobile, ibu hamil kini dapat mengakses berbagai materi edukasi seputar kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca-melahirkan kapan saja dan di mana saja.

Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi dapat digunakan untuk mengorganisir dan mengelola kelas ibu hamil dengan berbagai fitur, seperti jadwal video edukasi, konseling online dan dilengkapi dengan informasi terbaru yang dapat diakses baik secara online ataupun offline. Buku ini juga membahas dampak positif penggunaan aplikasi bagi peningkatan pengetahuan ibu hamil, pengurangan kecemasan, serta pemberdayaan mereka dalam merawat kesehatan diri dan janin.

Selain itu, buku ini mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi di kalangan ibu hamil, termasuk faktor literasi digital, akses internet, dan keterbatasan sumber daya. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi penyedia layanan kesehatan, pengembang aplikasi, dan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pendidikan kehamilan yang lebih inklusif dan terjangkau.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada teknologi, buku ini menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin memperkenalkan inovasi dalam pendidikan kesehatan ibu hamil.

Buku ini mengulas pengembangan kelas ibu hamil yang memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi untuk memberikan informasi dan layanan pendidikan kepada ibu hamil secara lebih efektif dan efisien. Dalam era digital, teknologi telah merambah berbagai sektor, termasuk dunia kesehatan. Dengan menggunakan aplikasi mobile, ibu hamil kini dapat mengakses berbagai materi edukasi seputar kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca-melahirkan kapan saja dan di mana saja.

Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi dapat digunakan untuk mengorganisir dan mengelola kelas ibu hamil dengan berbagai fitur, seperti jadwal video edukasi, konseling online dan dilengkapi dengan informasi terbaru yang dapat diakses baik secara online ataupun offline. Buku ini juga membahas dampak positif penggunaan aplikasi bagi peningkatan pengetahuan ibu hamil, pengurangan kecemasan, serta pemberdayaan mereka dalam merawat kesehatan diri dan janin.

Selain itu, buku ini mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi di kalangan ibu hamil, termasuk faktor literasi digital, akses internet, dan keterbatasan sumber daya. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi penyedia layanan kesehatan, pengembang aplikasi, dan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pendidikan kehamilan yang lebih inklusif dan terjangkau.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada teknologi, buku ini menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin memperkenalkan inovasi dalam pendidikan kesehatan ibu hamil.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-63-4



9

786347

139634